Formas del abdomen, piel, pared y hernias

SEMIOLOGIA · Clase 24 · globuloso, batracio y delantal; estrías y equimosis; diástasis, hernia y eventración

1 · EL ABDOMEN NORMAL Y CÓMO SE MIRA

Inspección
decúbito dorsal, extremidades extendidas, buena luz y examinador a la derecha; también de pie y haciendo toser

primero reconoce el

Abdomen normal F3 · F4
levemente convexo y simétrico; niño convexo, adulto joven plano, anciano globuloso

si pierde la simetría

si se hunde

si abomba

por la consunción

si sospecha hernia, mirar

después examina la piel y las

también hace toser para ver la

2 · QUÉ LO DEFORMA: LÍQUIDO, GRASA, GAS Y CONSUNCIÓN

Asimétrico F3 · F4
visceromegalias (bazo) o hernias

Retraído o excavado F3 · F4
consunción: rebordes óseos marcados

Globuloso F2 · F3 · F4
obesidad, ascitis, neoplasias, embarazo u obstrucción

si es líquido a tensión

si el líquido cae a los lados

si es grasa excesiva

Líquido a tensión F2
la ascitis de más de 1.500 ml empuja toda la pared y el ombligo protruye

De batracio F1 · F3 · F4
el líquido sin tensión cae a los flancos: flancos abombados y centro plano

Gran obeso F1
crece el panículo adiposo y cuelga sobre el pubis

se mide por volumen

se mide por volumen

da el abdomen

En delantal F1 · F3 · F4
propio del gran obeso

3 · ASCITIS: FORMA Y VOLUMEN

Ascitis > 1.500 ml
oleada positiva y matidez en flancos

confirma la ascitis

500 a 1.500 ml
matidez desplazable (decúbito dorsal y lateral)

si es menos todavía

< 500 ml
la percusión no alcanza: ecografía

pide confirmar con ecografía

4 · LA PIEL: ESTRÍAS Y MANCHAS

Estrías
roturas de la dermis por distensión (embarazo, obesidad, ascitis) o por piel frágil

busca el

si son anchas y violáceas

si son rosadas o nacaradas

Rojo violáceas F5
anchas y persistentes: síndrome de Cushing

Rosadas si son recientes, **nacaradas** si son antiguas F5
distensión, como el embarazo

Color de la piel F6
normalmente igual al resto del tegumento; la ictericia lo cambia

si hay equimosis en el ombligo

si hay equimosis en los flancos

si hay venas dilatadas

si hay máculas rosadas

reflejan distensión previa

orienta a Cushing

orienta a hipertensión portal o cava

Signo de Cullen F6
equimosis periumbilical; ombligo azulado

Signo de Grey Turner F6
equimosis en los flancos

Circulación colateral F6
tipo porta, cava superior o cava inferior

Roséolas tíficas F6
máculo-pápulas rosadas de 1 a 3 cm, escasas, que blanquean a la presión

se debe a

se debe a

se deben a

por eso orienta a hemorragia

por eso orienta a tifoidea

Hemorragia intra o retroperitoneal F6
pancreatitis hemorrágica, embarazo ectópico roto

Fiebre tifoidea F6
al final de la primera semana

5 · LA PARED QUE CEDE

Maniobra de Valsalva F8
pujar con la glotis cerrada o toser: sube la presión y la zona débil protruye

hace evidente la

hace evidente la

Hernia F7
salida de un órgano o parte de él con saco por un orificio natural o adquirido

se distingue de la

y de la

si es inguinal, se palpa con la

Diástasis F7
separación de los rectos en la línea media, sin saco

Eventración F7
protrusión de vísceras por una cicatriz quirúrgica (literatura)

Hernia inguinal (literatura) F9
paciente de pie: el índice invagina el escroto hasta el anillo y se pide toser; punta del dedo: indirecta; pulpejo: directa

por su causa orienta a

sin saco orienta a

en cicatriz orienta a

confirma la hernia inguinal

6 · QUÉ ORIENTA LA INSPECCIÓN

Las roséolas orientan a fiebre tifoidea

Forma y piel orientan a ascitis, obesidad, consunción, Cushing o hemorragia

Un defecto de la pared orienta a diástasis, hernia o eventración

técnica · signo · mecanismo · diagnóstico · concepto · desenlace · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clase 09b y 09e · Sotomayor — teoría del docente (= literatura: palpación de la hernia inguinal y eventración)